CH FICTIF DES TILLEULS
17, allée des Fictifs
BP 60417
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.04.17

Finess 33 0 99997 3
Siret 200 000 417 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HOURCADE DELPHINE
Né(e) le 09/04/1977 (48 ans) à ARCACHON (33)
IPP 0000930576

Admission A224067734
mer. 11/09/24 15:00 (419 nuits)

Méd. CASTJE - CASTAING JEROME
UFM 4417 - CSAP
UFH 4417 - CSAP

Poids 67 kg
Taille 163 cm
IMC 25.22
SC 1.73 m²

Observation psychiatrique de suivi du 28/10/2025 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 04/11/2025 à 06:01 par LACROUTS SOLÈNE

Observations :
Vue ce jour à J14 de la première injection de buprénorphine LP mensuelle.
Bonne tolérance, induration minime au point d'injection, régressive. Pas de signe de manque en fin de mois attendu (à réévaluer à J28). Soulagée de "ne plus y penser tous les matins".
Douleurs stables, EVA 4.
Conclusions :
2e injection le 11/11 (IDE)
RDV décembre

Entretien infirmier du 14/10/2025 (Urgence : Bas)

Validé par PRADEAU Sonia - IDE le 14/10/2025 à 11:30

Première injection sous-cutanée de buprénorphine LP mensuelle 96 mg (abdomen), dernière prise de BHD sublinguale 14 mg hier matin. Surveillance 1h : RAS. Explications sur la prochaine injection.
Tabac toujours 10 cig/j.

Observation psychiatrique de suivi du 09/09/2025 (Urgence : Bas)

Validé par LACROUTS Solène - Médecin le 09/09/2025 à 17:05

Observations :
Vue ce jour
Son fils Mathis est parti le 01/09 pour ses études à Toulouse, tristesse attendue, "la maison est vide". Pas d'effondrement thymique.
BHD 14 mg/j, pas de reprise d'oxycodone depuis avril. Contrainte des passages en pharmacie mal vécue.
Proposition de buprénorphine LP injectable mensuelle : accord.
Conclusions :
Relais par injection mensuelle (96 mg) le 14/10
RO BHD 14 mg et duloxétine 60 mg jusqu'au relais

Observation psychiatrique de suivi du 17/06/2025 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 24/06/2025 à 06:00 par LACROUTS SOLÈNE

Observations :
Vue ce jour
Thymie meilleure, marche 30 minutes par jour, piscine 1 fois par semaine (APA). EVA 4/10.
Revient sur avril : dit avoir pris de l'oxycodone "une seule fois".
BHD diminuée à 14 mg/j a sa demande depuis le 01/06, sans manque.
Conclusions :
RO BHD 14 mg, duloxétine 60 mg
RDV septembre

Observation psychiatrique de suivi du 06/05/2025 (Urgence : Bas)

CH FICTIF DES TILLEULS
17, allée des Fictifs
BP 60417
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.04.17

Finess 33 0 99997 3
Siret 200 000 417 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HOURCADE DELPHINE
Né(e) le 09/04/1977 (48 ans) à ARCACHON (33)
IPP 0000930576

Admission A224067734
mer. 11/09/24 15:00 (419 nuits)

Méd. CASTJE - CASTAING JEROME
UFM 4417 - CSAP
UFH 4417 - CSAP

Poids 67 kg
Taille 163 cm
IMC 25.22
SC 1.73 m²

Validé par LACROUTS Solène - Médecin le 06/05/2025 à 12:15

Observations :
Vue ce jour
Reprise d'oxycodone mi-avril pendant 3 jours lors d'une poussée douloureuse : a retrouvé d'anciennes boites dans un tiroir. En a parlé d'elle-même à son mari puis à l'IDE. Boites rapportées à la pharmacie ensuite.
Pas de surdosage, pas d'autre prise. Craving faible depuis.
Analyse de la situation : la douleur reste le déclencheur principal, plan de crise douleur écrit avec le CETD.
Conclusions :
BHD 16 mg maintenue
RDV juin

Entretien infirmier du 11/03/2025 (Urgence : Bas)

Validé par PRADEAU Sonia - IDE le 11/03/2025 à 10:00

Urines : buprénorphine +, opiacés -, oxycodone -, BZD -. Pas d'alcool.
Tabac 10 cig/j, pas prête à arreter. Pas de signes de manque.

Observation somatique de suivi du 21/01/2025 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 28/01/2025 à 06:02 par LACROUTS SOLÈNE

Observations :
CR de consultation du CETD (Dr CAPDEVIELLE, 13/01) : lombalgie chronique post-arthrodèse L4-L5 et syndrome fibromyalgique. Pas d'indication chirurgicale. Programme : activité physique adaptée, TENS, balnéothérapie. Avis favorable au maintien de la buprénorphine, en 2 prises.
Conclusions :

Observation psychiatrique de suivi du 26/11/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LACROUTS Solène - Médecin le 26/11/2024 à 16:40

Observations :
Vue ce jour
Thymie basse depuis plusieurs mois, anhédonie, fatigue, culpabilité vis-à-vis de sa famille ("j'ai failli mourir devant mon fils"). Pas d'idées suicidaires. Épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne, probablement ancien (depuis le licenciement).
Pas d'oxycodone depuis l'induction, EVA 6/10.
Conclusions :
Duloxétine 30 mg puis 60 mg à J15 (douleur + thymie)
Orientation CETD
RDV 1 mois

Entretien social du 05/11/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LAMOTHE Coralie - Assistante sociale le 05/11/2024 à 14:00

Mme HOURCADE Delphine, née le 09/04/1977, 15 rue de la Forge, 33380 BIGANOS. Tél : 06 72 09 84 16.

CH FICTIF DES TILLEULS
17, allée des Fictifs
BP 60417
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.04.17

Finess 33 0 99997 3
Siret 200 000 417 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HOURCADE DELPHINE
Né(e) le 09/04/1977 (48 ans) à ARCACHON (33)
IPP 0000930576

Admission A224067734
mer. 11/09/24 15:00 (419 nuits)

Méd. CASTJE - CASTAING JEROME
UFM 4417 - CSAP
UFH 4417 - CSAP

Poids 67 kg
Taille 163 cm
IMC 25.22
SC 1.73 m²

Ancienne agent d'entretien, licenciée pour inaptitude en juin 2023. Indemnités chômage jusqu'en mars 2025. Démarches : RQTH, demande de pension d'invalidité auprès de la CPAM. Son mari Ludovic (chauffeur) est le seul revenu stable.

Observation psychiatrique de suivi du 15/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 22/10/2024 à 06:01 par LACROUTS SOLÈNE

Observations :
Vue ce jour à J15 de l'induction.
BHD 16 mg/j en 2 prises (8 + 8) pour la couverture antalgique. Pas d'oxycodone. A pris 2 comprimés de tramadol un soir "pour voir", sans effet.
Douleurs EVA 6/10 (7 avant), "pas pire qu'avec l'oxy", moins de somnolence. Son mari trouve qu'elle "est revenue".
Conclusions :
RO BHD 16 mg, délivrance hebdomadaire pharmacie
Tramadol : à ne pas associer, explications
RDV fin novembre

Observation psychiatrique de suivi du 01/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LACROUTS Solène - Médecin le 01/10/2024 à 18:00

Observations :
Induction de buprénorphine hier au CSAPA (30/09). Dernière prise d'oxycodone le 29/09 au soir. COWS à 13 à l'arrivée : 4 mg, puis 4 mg à H2. J2 : 12 mg.
Ce jour : pas de manque, un peu de nausées. Douleurs dorsales "comme d'habitude".
Conclusions :
BHD 16 mg/j
Kit de naloxone remis + formation de son mari

Entretien infirmier du 19/09/2024 (Urgence : Bas)

Validé par PRADEAU Sonia - IDE le 19/09/2024 à 09:30

Préparation de l'induction. Explications sur le délai sans opioïde avant la première prise (manque modéré nécessaire).
Urines : oxycodone +, tramadol +, BZD -.
La patiente dit être "sous antalgiques forts depuis 5 ans".

Motif de l'évaluation du 11/09/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 18/09/2024 à 06:02 par LACROUTS SOLÈNE

Observations :
Patiente vue ce jour en premier entretien, adressée par son MG apres un passage aux urgences le 17/08/2024 : somnolence, chute, bradypnée, retrouvée par son fils, naloxone par le SMUR.
Antécédents :
Médicaux :
- lombalgie chronique, arthrodèse L4-L5 en 2021
- fibromyalgie évoquée

CH FICTIF DES TILLEULS
17, allée des Fictifs
BP 60417
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.04.17

Finess 33 0 99997 3
Siret 200 000 417 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HOURCADE DELPHINE
Né(e) le 09/04/1977 (48 ans) à ARCACHON (33)
IPP 0000930576

Admission A224067734
mer. 11/09/24 15:00 (419 nuits)

Méd. CASTJE - CASTAING JEROME
UFM 4417 - CSAP
UFH 4417 - CSAP

Poids 67 kg
Taille 163 cm
IMC 25.22
SC 1.73 m²

Psychiatriques : pas de suivi, pas de TS.
Opioïdes :
- tramadol depuis 2020, puis oxycodone depuis la chirurgie (2021), poursuivie par le MG
- courrier du MG : oxycodone 60 mg/j prescrits
- en réalité : oxycodone LP 40 mg x 2 + LI 10 mg jusqu'à 4/j, soit environ 120 mg/j, complétés par des ordonnances des urgences et d'un second médecin, plus du tramadol
- effet recherché au-delà de la douleur : "ça m'apaise", prises le soir pour "oublier"

Alcool : aucun. Tabac 10 cig/j.
Cliniquement, contact de qualité, émue, honte ++. Ralentissement, myosis. Thymie basse.
Trouble de l'usage des opioïdes sévère, sur douleur chronique.

Conclusions :
- Proposition d'un relais par buprénorphine, accord
- Préparation avec l'IDE, induction le 30/09
- Unique prescripteur d'opioïdes : le CSAPA (MG d'accord)